ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

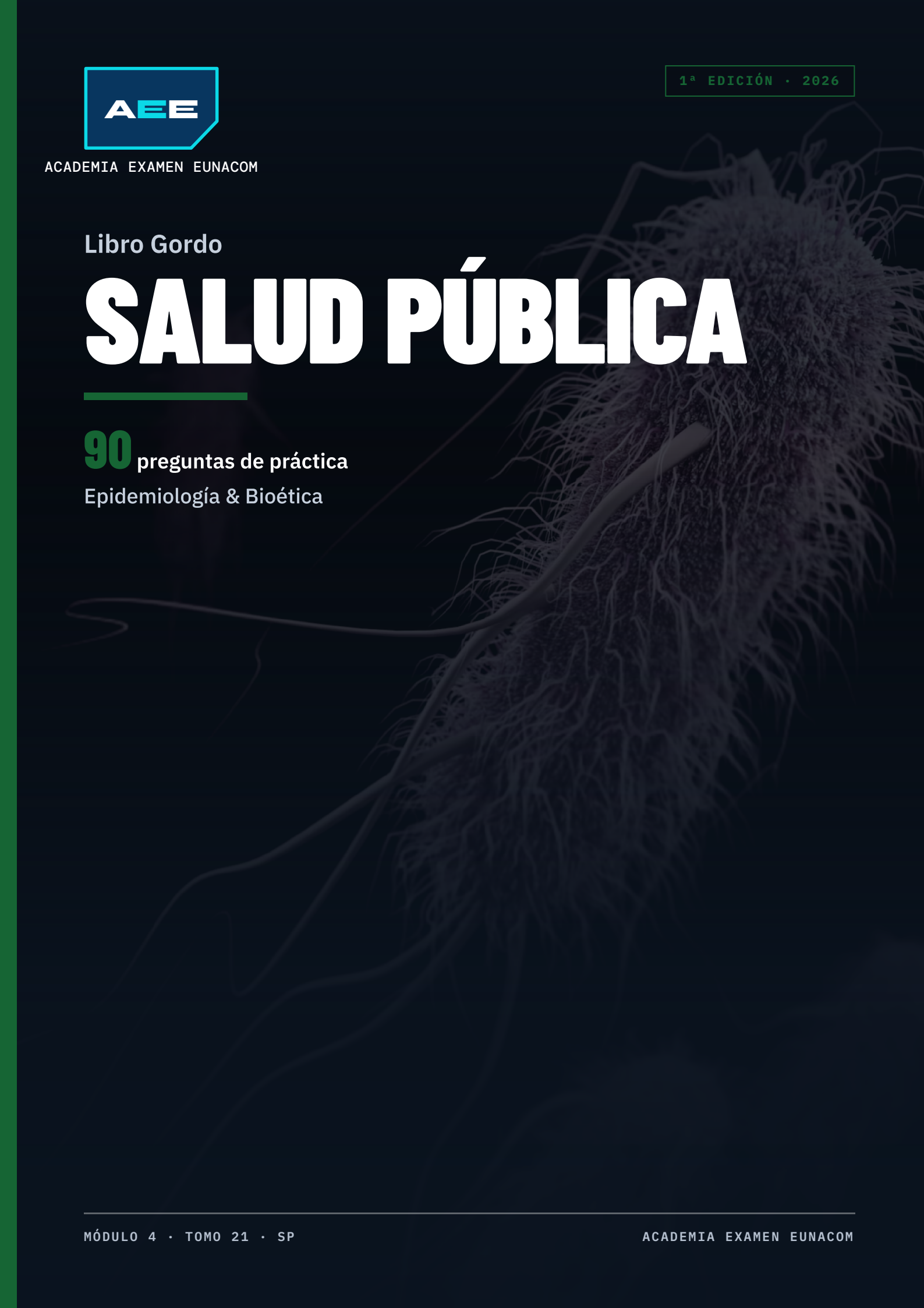
1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

SALUD PÚBLICA

90 preguntas de práctica

Epidemiología & Bioética



MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Salud Pública · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

TOMO 21 · PARTE A: POR BLOQUES

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA					
7.01.3.002	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.004	Niveles de prevención	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.006	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q4	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.007	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q5	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.009	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q6	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.025	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.027	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q7	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.029	Descripción sistemática de problemas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.031	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q14	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.032	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q15	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.034	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q16	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.035	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q17	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.036	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 21 · 21.1 (Pág. 5)
7.01.3.037	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q9	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.038	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q10	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.039	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.040	Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg:	GES	Q13	Tomo 21 · 21.2 (Pág. 9)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Garantías Legales y Reclamos	**Derivar**			
7.01.3.042	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q12	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
BLOQUE 2: SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA					
7.01.3.001	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Evaluación Biopsicosocial** Tx: **Plan de Cuidado Familiar** · Seg: **Sector Sanitario / CESFAM**	GES	Q23	Tomo 21 · 21.5 (Pág. 19)
7.01.3.003	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.005	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.008	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q24	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.010	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q25	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.011	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q26	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.012	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q27	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.013	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q29	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.014	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q30	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.015	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q21	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.016	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q22	Tomo 21 · 21.4 (Pág. 15)
7.01.3.017	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q28	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.018	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q31	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.020	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q32	Tomo 21 · 21.6 (Pág. 24)
7.01.3.021	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q33	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.022	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q34	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
7.01.3.023	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q35	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.024	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q36	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
BLOQUE 3: EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE					
7.01.3.019	Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q46, Q47, Q48	Tomo 21 · 21.7 (Pág. 28)
7.01.3.026	Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q52, Q53, Q54	Tomo 21 · 21.9 (Pág. 36)
7.01.3.028	Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q49, Q50, Q51	Tomo 21 · 21.8 (Pág. 32)
7.01.3.033	Bases conceptuales de la seguridad social	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.043	Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q44	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.044	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q41	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.046	Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.047	Auditoría y acreditación	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.049	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q42	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.050	Rol del médico en la generación y uso de la información	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q40	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.053	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q45	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.055	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q43	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
BLOQUE 4: EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE					
7.01.3.028	Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos	Dx: **Fase Preclínica Detectable** Tx: **Intervención Precoz Eficaz** · Seg: **Evaluación de Programas**	GES	Q56, Q57, Q58, Q59, Q60	Tomo 21 · 21.8 (Pág. 32)
7.01.3.030	Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q61	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.041	Conceptos de administración y gestión	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
7.01.3.052	Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q62, Q63, Q64, Q65, Q66, Q67	Tomo 21 · 21.11 (Pág. 43)
7.01.3.056	Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q68, Q69, Q70, Q71, Q72	Tomo 21 · 21.12 (Pág. 47)
BLOQUE 5: BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO					
7.01.3.045	Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordinación	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.051	Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79, Q80, Q81, Q82	Tomo 21 · 21.13 (Pág. 49)
7.01.3.054	Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q83, Q84, Q85, Q86, Q87, Q88, Q89, Q90	Tomo 21 · 21.14 (Pág. 53)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Salud Pública · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
7.01.3.001	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Evaluación Biopsicosocial** Tx: **Plan de Cuidado Familiar** · Seg: **Sector Sanitario / CESFAM**	GES	Q23	Tomo 21 · 21.5 (Pág. 19)
7.01.3.002	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q3	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.003	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q19	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.004	Niveles de prevención	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.005	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q20	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.006	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q4	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.007	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q5	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.008	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q24	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.009	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q6	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.010	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q25	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.011	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q26	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.012	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q27	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.013	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q29	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.014	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q30	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.015	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q21	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.016	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q22	Tomo 21 · 21.4 (Pág. 15)
7.01.3.017	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg:	—	Q28	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	(MAIS) y Diagnóstico Comunitario	**Derivar**			
7.01.3.018	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q31	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.019	Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q46, Q47, Q48	Tomo 21 · 21.7 (Pág. 28)
7.01.3.020	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q32	Tomo 21 · 21.6 (Pág. 24)
7.01.3.021	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q33	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.022	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q34	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.023	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q35	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.024	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q36	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.025	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q18	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.026	Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q52, Q53, Q54	Tomo 21 · 21.9 (Pág. 36)
7.01.3.027	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q7	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.028	Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q49, Q50, Q51, Q56, Q57, Q58, Q59, Q60	Tomo 21 · 21.8 (Pág. 32)
7.01.3.029	Descripción sistemática de problemas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.030	Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q61	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.031	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q14	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.032	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q15	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.033	Bases conceptuales de la seguridad social	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.034	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q16	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.035	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q17	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.036	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q8	Tomo 21 · 21.1 (Pág. 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
7.01.3.037	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q9	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.038	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q10	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.039	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q11	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.040	Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q13	Tomo 21 · 21.2 (Pág. 9)
7.01.3.041	Conceptos de administración y gestión	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.042	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q12	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.043	Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q44	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.044	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q41	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.045	Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordinación	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q73	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.046	Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q38	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.047	Auditoría y acreditación	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q39	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.049	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q42	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.050	Rol del médico en la generación y uso de la información	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q40	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.051	Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79, Q80, Q81, Q82	Tomo 21 · 21.13 (Pág. 49)
7.01.3.052	Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q62, Q63, Q64, Q65, Q66, Q67	Tomo 21 · 21.11 (Pág. 43)
7.01.3.053	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q45	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.054	Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q83, Q84, Q85, Q86, Q87, Q88, Q89, Q90	Tomo 21 · 21.14 (Pág. 53)
7.01.3.055	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q43	Tomo 21 · Salud Pública (Pág. 8)
7.01.3.056	Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg:	GES	Q68, Q69, Q70, Q71,	Tomo 21 · 21.12 (Pág. 47)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Clínica y Confidencialidad	Derivar		Q72	

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

PREGUNTA 1 7.01.3.004

1. **¿A qué concepto corresponde la siguiente definición: “Conjunto de medidas des8nadas a evitar que una enfermedad ocurra, actuando antes de que exista la enfermedad o el daño causado por esta”?**

A) Prevención primaria
B) Prevención secundaria
C) Prevención terciaria
D) Prevención cuaternaria
E) Promoción de la salud

PREGUNTA 2 7.01.3.029

2. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Descripción sistemática de problemas · 7.01.3.029] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Descripción sistemática de problemas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 3 7.01.3.002

3. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Funciones esenciales de la Salud Pública · 7.01.3.002] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Funciones esenciales de la Salud Pública. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 4 7.01.3.006

4. **Según la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, ¿cuál de los siguientes factores tiene mayor impacto en la salud de la población?**

A) Nivel educacional
B) Vivienda
C) Alimentación
D) Ingreso económico
E) Acceso a servicios de salud

PREGUNTA 5 7.01.3.007

5. **En una zona rural del país se recibe una gran can8dad de migrantes, principalmente personas jóvenes y sanas. Desde el punto de vista de la ges8ón en salud pública para dicha zona, ¿qué medida debe priorizarse?**

A) Aumentar los recursos para el programa de enfermedades crónicas
B) Aumentar los recursos para los programas de atención materno-infan2l
C) Reforzar los programas de saneamiento básico
D) Realizar empadronamiento de los migrantes
E) Aumentar el número de camas hospitalarias

PREGUNTA 6 7.01.3.009

6. ¿Cuál es el mejor indicador para medir la efectividad de la campaña de vacunación contra la influenza?

A) La tasa de mortalidad por influenza
B) La tasa de letalidad de la influenza
C) La tasa de incidencia de influenza
D) La tasa de prevalencia de influenza
E) La tasa de cobertura de vacunación contra la influenza

PREGUNTA 7 7.01.3.027

7. [ATENCIÓN PRIMARIA: Investigación epidemiológica · 7.01.3.027] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Investigación epidemiológica. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 8 7.01.3.036

8. Una empresa extranjera dedicada a otorgar prestaciones en salud decide iniciar sus operaciones en Chile, para lo cual solicita saber cuál es la ins8tución que actúa como laboratorio de referencia para todos los laboratorios, tanto públicos como privados, en el país. ¿Cuál es la respuesta correcta?

A) Central fíacional de Abastecimiento
B) Ins2tuto de Salud Pública
C) Superintendencia de Salud
D) Servicio Médico Legal
E) Secretaría Regional Ministerial de Salud

PREGUNTA 9 7.01.3.037

9. [ATENCIÓN PRIMARIA: Política sanitaria y objetivos sanitarios en Chile · 7.01.3.037] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Política sanitaria y objetivos sanitarios en Chile. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 10 7.01.3.038

10. Las instituciones de salud previsional y el seguro público de salud tienen en salud que:

A) Administrar el seguro de cotización individual
B) Administran el seguro público de salud
C) Administrar los fondos para las garantías de salud, comprendidas en el plan AUGE
D) Administran el seguro general de salud
E) Dan prestaciones de salud

PREGUNTA 11 7.01.3.039

11. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un centro de atención secundaria?

A) CESFAM
B) CECOSF
C) Posta de salud rural
D) Hospital comunitario de familia
E) COSAM

PREGUNTA 12 7.01.3.042

12. En gestión de salud, ¿cuál es la diferencia entre planificación y programación?

A) La planificación se refiere a objetivos y recursos específicos, mientras que la programación es global
B) La planificación es a largo plazo, mientras que la programación es anual
C) La programación, a diferencia de la planificación, debe ser concordante con la misión y la visión de la institución
D) La planificación se basa en lo determinado con la programación
E) La planificación se relaciona a los costes y recursos de actividades concretas y la programación se relaciona con el presupuesto general del proyecto

PREGUNTA 13 7.01.3.040

13. **Una paciente de 36 años presenta un trabajo de parto prematuro a las 28 semanas con resultado de mor8nato de 800 g y anencefalia. Según la norma8va vigente, ¿por cuánto 8empo debe recibir descanso laboral?**

A) 7 días
B) 10 días
C) 6 semanas
D) 12 semanas
E) 24 semanas

PREGUNTA 14 7.01.3.031

14. **Durante una pandemia respiratoria, el Ministerio de Salud debe decidir la intervención de salud pública con mayor impacto para reducir la mortalidad poblacional a largo plazo. ¿Cuál es la medida más eficaz?**

A) Profilaxis antibiótica masiva
B) Desinfección ambiental de espacios públicos
C) Cuarentena de contactos
D) Vacunación masiva de la población
E) Aislamiento de casos positivos solamente

PREGUNTA 15 7.01.3.032

15. **¿Cuál es el mejor indicador para determinar si un programa de tamizaje del cáncer de mama es efectivo?**

A) Tasa de incidencia de cáncer de mama
B) Tasa de prevalencia de cáncer de mama
C) Tasa de letalidad de cáncer de mama
D) Tasa de mortalidad de cáncer de mama
E) Tasa de positividad de las pruebas de tamizaje del cáncer de mama

PREGUNTA 16 7.01.3.034

16. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Desarrollo histórico de seguridad social y atención de salud · 7.01.3.034] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Desarrollo histórico de seguridad social y atención de salud. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 17 7.01.3.035

17. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Funciones de los sistemas de atención de salud · 7.01.3.035] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Funciones de los sistemas de atención de salud. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 18 7.01.3.025

18. **En un estudio se realiza medición de los niveles plasmáticos de pesticidas a personas de distintos países, obteniéndose los niveles promedios para la población de cada país. Luego, se correlaciona con las tasas de mortalidad por cáncer de cada país. ¿A qué tipo de estudio corresponde?**

A) Observacional
B) Cohortes
C) Experimental
D) Ecológico
E) De contraste de hipótesis

PREGUNTA 19 7.01.3.003

19. [ATENCIÓN PRIMARIA: Historia natural de la enfermedad · 7.01.3.003] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Historia natural de la enfermedad. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 20 7.01.3.005

20. [ATENCIÓN PRIMARIA: Promoción de salud y prevención de enfermedades · 7.01.3.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Promoción de salud y prevención de enfermedades. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 21 7.01.3.015

21. ¿Cuál es el mejor indicador para determinar el éxito de una campaña de vacunación?

A) Tasa de incidencia
B) Tasa de prevalencia
C) Tasa de hospitalizaciones
D) Tasa de mortalidad
E) Tasa de cobertura de vacunación

PREGUNTA 22 7.01.3.016

22. El médico de un CESFAM detecta un brote de hepatitis A en su sector. ¿A qué autoridad sanitaria debe notificar de forma inmediata?

A) SEREMI de Salud
B) Ministerio de Salud directamente
C) FONASA
D) ISP
E) Municipalidad

PREGUNTA 23 7.01.3.001

23. Durante la realización de un estudio de familia en un CESFAM, se aplica el cuestionario de APGAR familiar a un adolescente de 15 años con conductas de riesgo y deserción escolar, obteniendo un puntaje total de 5 puntos. ¿Cómo se clasifica la funcionalidad de su sistema familiar según este resultado?

A) Disfunción familiar leve
B) Familia altamente funcional
C) Disfunción familiar severa
D) Familia desestructurada con riesgo de abandono
E) Sistema familiar con aglutinamiento patológico

PREGUNTA 24 7.01.3.008

24. [ATENCIÓN PRIMARIA: Diagnóstico de situación de salud: · 7.01.3.008] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Diagnóstico de situación de salud:. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 25 7.01.3.010

25. La última fase del diagnóstico de salud participativo es:

A) La comprobación de los problemas de salud, referidos por la comunidad
B) La determinación de estadísticas y datos objetivos y completos
C) La determinación de la prevalencia de las patologías más importantes de la comunidad
D) La definición de estrategias de intervención, priorizadas
E) Realización de estudios experimentales

PREGUNTA 26 7.01.3.011

26. [ATENCIÓN PRIMARIA: Fuentes de información para el diagnóstico · 7.01.3.011] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Fuentes de información para el diagnóstico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 27 7.01.3.012

27. [ATENCIÓN PRIMARIA: Ejecución de un diagnóstico · 7.01.3.012] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Ejecución de un diagnóstico. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 28 7.01.3.017

28. [ATENCIÓN PRIMARIA: Usos de la epidemiología en el diagnóstico de situación de salud · 7.01.3.017] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Usos de la epidemiología en el diagnóstico de situación de salud. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 29 7.01.3.013

29. [ATENCIÓN PRIMARIA: Concepto y campo de la epidemiología · 7.01.3.013] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Concepto y campo de la epidemiología. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 30 7.01.3.014

30. Si se quiere hacer un estudio donde se describe en un grupo de niños cuales son los FR, edad, enfermedades?, cómo se llamaría:

A) Analitico

B) Ecológico

C) Descriptivo

D) Control sano habitual

E) Derivar a especialista

PREGUNTA 31 7.01.3.018

31. **¿Qué rama de la Salud Pública se preocupa de obtener información, a través del contraste de hipótesis?**

A) Epidemiología descriptiva
B) Bioestadística
C) Prevención de salud
D) Epidemiología analítica
E) Vigilancia epidemiológica

PREGUNTA 32 7.01.3.020

32. **¿Cuál es el mejor diseño de estudio epidemiológico que entrega evidencia de mayor calidad, para buscar la asociación entre una exposición y una enfermedad en una po- blación?**

A) Estudio de serie de casos
B) Estudio de series temporales
C) Estudio de casos y controles
D) Estudio de cohorte
E) Estudio clínico no randomizado

PREGUNTA 33 7.01.3.021

33. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Estudios de prevalencia · 7.01.3.021] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Estudios de prevalencia. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 34 7.01.3.022

34. **¿Cuál es el diseño de estudio más adecuado para estudiar enfermedades muy infrecuentes?**

A) Cohortes prospectivas
B) Caso control
C) De prevalencia
D) Ensayo clínico
E) Cohortes retrospectiva

PREGUNTA 35 7.01.3.023

35. **Se realiza un estudio donde se comparan dos grupos de personas mayores de 60 años, uno de ellos corresponde a hipertensos y el otro de características similares pero sin hipertensos, se siguen por 5 años y se evalúa la aparición de infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular. Este enunciado corresponde a un estudio de:**

A) Corte transversal
B) Caso control
C) Estudio clínico randomizado
D) Cohorte
E) Ensayo de campo

PREGUNTA 36 7.01.3.024

36. **La característica de los estudios experimentales, que los diferencian de los demás tipos de estudios es que:**

A) La selección es aleatorizada
B) Siempre utiliza triple ciego
C) El investigador controla algunas variables
D) El investigador selecciona los grupos de intervención
E) Utiliza test de hipótesis

BLOQUE 3 EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

PREGUNTA 37 7.01.3.033

37. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Bases conceptuales de la seguridad social · 7.01.3.033] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Bases conceptuales de la seguridad social. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 38 7.01.3.046

38. En un programa de detección precoz de cáncer de mama, ¿qué función cumple la medición de la tasa de mortalidad específica por dicha enfermedad?

A) Permite determinar el grado de cobertura del programa
B) Contribuye a evaluar la calidad del proceso de atención en el programa
C) Permite obtener una variable indirecta que refleja la efec2vidad del programa
D) Permite evaluar la eficiencia del proceso de aplicación del programa
E) Refleja el impacto del programa

PREGUNTA 39 7.01.3.047

39. ¿A qué tipo de garantía corresponde el registro de los profesionales de la salud en el Registro de Prestadores Individuales, llevado por la Superintendencia de Salud, en contexto del programa de Garantías Explícitas de Salud (GES)?

A) Garantía de acceso universal
B) Garantía de protección financiera
C) Garantía de calidad en la atención
D) Garantía de oportunidad en la atención
E) Garantía de acceso a la información

PREGUNTA 40 7.01.3.050

40. [ATENCIÓN PRIMARIA: Rol del médico en la generación y uso de la información · 7.01.3.050] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Rol del médico en la generación y uso de la información. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 41 7.01.3.044

41. [ATENCIÓN PRIMARIA: Organización: principios y características estructurales y funcionales de las organizaciones · 7.01.3.044] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Organización: principios y características estructurales y funcionales de las organizaciones. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 42 7.01.3.049

42. ¿Cómo se financia el Plan de Salud Familiar, ofrecido por el sistema de atención primaria de salud de Chile?

A) Transferencias por prestaciones otorgadas
B) Aportes de fondos municipales
C) Transferencias por plan de salud
D) Aporte per cápita, en razón del número de inscritos
E) Copago de los usuarios

PREGUNTA 43 7.01.3.055

43. [ATENCIÓN PRIMARIA: Conceptos básicos de administración de establecimientos de salud · 7.01.3.055] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Conceptos básicos de administración de establecimientos de salud. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 44 7.01.3.043

44. [ATENCIÓN PRIMARIA: Formulación de programas · 7.01.3.043] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Formulación de programas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 45 7.01.3.053

45. [ATENCIÓN PRIMARIA: Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda · 7.01.3.053] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 46 7.01.3.019

46. Se busca la asociación entre distintos parámetros con el cáncer de tiroides, en un estudio de caso – control, con el Odds Ratio (OR), más un intervalo de confianza (IC) al 95%. ¿Qué factor es más importante en esta asociación?

A) Antecedentes familiares: OR: 1,88 ; IC [0,56 – 4,01]

B) Edad: OR: 2,6 ; IC [0,95 – 3,17]

C) Sexo masculino: OR: 0,56 ; IC [0,33 – 0,87]

D) Exposición a radiación: OR: 1,52 ; IC [0,91 – 2,01]

E) Tiroiditis de Hashimoto: OR: 4,6 ; IC [0,7 – 6,2]

PREGUNTA 47 7.01.3.019

47. En un ensayo clínico controlado que compara un nuevo anticoagulante oral directo (DOAC) frente a warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular, la incidencia acumulada de accidente cerebrovascular isquémico a 3 años fue de 2% en el grupo DOAC y de 6% en el grupo warfarina. ¿Cuál es la Reducción Relativa del Riesgo (RRR) y el Número Necesario a Tratar (NNT) del nuevo fármaco?

A) RRR = 66,7% y NNT = 25 pacientes

B) RRR = 4% y NNT = 50 pacientes

C) RRR = 33,3% y NNT = 20 pacientes

D) RRR = 50% y NNT = 40 pacientes

E) RRR = 66,7% y NNT = 100 pacientes

PREGUNTA 48 7.01.3.019

48. Un estudio de cohortes prospectivo analiza la relación entre tabaquismo pesado y la incidencia de enfermedad arterial oclusiva periférica. El análisis multivariado arroja un Riesgo Relativo (RR) de 1,65 con un Intervalo de Confianza del 95% (IC 95%) de 0,85 a 2,45. ¿Cuál es la interpretación metodológicamente correcta de este resultado?

A) No se puede descartar que la asociación observada se deba al azar, ya que el intervalo de confianza incluye el valor nulo (1,0).

B) El tabaquismo pesado incrementa significativamente el riesgo de arteriopatía periférica en un 65% con $p < 0,01$.

C) Existe un factor protector limítrofe demostrado por el límite inferior menor a 1.

D) El estudio adolece de un error tipo I (alfa) al haber rechazado incorrectamente la hipótesis nula.

E) La medida de asociación es inválida debido a que debió calcularse un Odds Ratio en lugar de Riesgo Relativo.

PREGUNTA 49 7.01.3.028

49. Si se quiere determinar la utilidad de una prueba diagnóstica, ¿Qué técnica es la más adecuada?

A) Elaboración de curvas de ROC

B) Determinar la sensibilidad y especificidad de la prueba

C) Determinar la sensibilidad de la prueba y la prevalencia de la enfermedad

D) Determinar la especificidad y el valor predictivo negativo de la prueba

E) Determinar el número necesario para tratar (NNT)

PREGUNTA 50 7.01.3.028

50. Un test de cribado con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 90% se aplica en dos poblaciones diferentes: la Población 1 (donde la prevalencia de la enfermedad es del 1%) y la Población 2 (donde la prevalencia es del 25%). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los valores predictivos del test en ambas poblaciones es correcta?

A) El Valor Predictivo Positivo (VPP) será significativamente mayor en la Población 2 que en la Población 1.

B) El Valor Predictivo Positivo será idéntico en ambas poblaciones porque la sensibilidad y especificidad no cambian.

C) El Valor Predictivo Negativo (VPN) será mayor en la Población 2 que en la Población 1.

D) La Sensibilidad de la prueba aumentará en la Población 2 al haber mayor número de enfermos.

E) La Especificidad de la prueba disminuirá en la Población 1 debido al bajo número de casos.

PREGUNTA 51 7.01.3.028

51. **¿Cuál es la principal utilidad clínica de una prueba diagnóstica que cuenta con una Sensibilidad del 99% y una Especificidad del 65%?**

A) Descartar la presencia de la enfermedad ante un resultado negativo del test.
B) Confirmar con certeza absoluta el diagnóstico ante un resultado positivo del test.
C) Determinar el pronóstico y sobrevida a largo plazo de los pacientes confirmados.
D) Reemplazar a la biopsia como estándar de oro terapéutico definitivo.
E) Evitar la realización de pruebas de confirmación en aquellos pacientes que resulten positivos.

PREGUNTA 52 7.01.3.026

52. **Un problema de los estudios de casos y controles es que, al ser retrospectivo, las personas evaluadas olvidan las situaciones a las que estuvieron expuestos. Aquello produce un tipo de error sistemático, que corresponde a un:**

A) Error de clasificación diferencial
B) Sesgo de selección
C) Sesgo de confusión
D) Sesgo de información
E) Error de clasificación no diferencial

PREGUNTA 53 7.01.3.026

53. **¿Cuál de los siguientes criterios epidemiológicos de Austin Bradford Hill es el ÚNICO considerado absolutamente indispensable (condición sine qua non) para poder postular una relación de causalidad entre una exposición y una enfermedad?**

A) Temporalidad
B) Fuerza de asociación (magnitud del Riesgo Relativo)
C) Plausibilidad biológica
D) Gradiente biológico (relación dosis-respuesta)
E) Especificidad de la causa

PREGUNTA 54 7.01.3.026

54. **Un estudio observacional encuentra que las personas que consumen café presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de laringe en comparación con los no bebedores. Sin embargo, al estratificar el análisis según el hábito tabáquico, se observa que tanto entre los fumadores como entre los no fumadores el consumo de café no modifica la incidencia del cáncer. ¿Qué fenómeno epidemiológico explica este hallazgo?**

A) El tabaquismo actuaba como una variable de confusión en la asociación aparente.
B) El estudio adolecía de un sesgo de selección de tipo Berkson.
C) Ocurrió una falacia ecológica al extrapolar datos de consumo poblacional.
D) El consumo de café produjo modificación del efecto en pacientes fumadores.
E) Hubo una violación al criterio de plausibilidad biológica de Bradford Hill.

BLOQUE 4 EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

PREGUNTA 55 7.01.3.041

55. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Conceptos de administración y gestión · 7.01.3.041] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Conceptos de administración y gestión. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 7.01.3.028

56. **¿Cuál de las siguientes condiciones es un criterio indispensable de acuerdo con los postulados de Wilson y Jungner de la OMS para justificar éticamente la implementación de un programa de tamizaje poblacional masivo?**

A) Disponibilidad de un tratamiento eficaz y comprobado que brinde mayor beneficio al aplicarse en etapa preclínica que en etapa sintomática.
B) Que la enfermedad sea de curso agudo y fulminante sin período de latencia prolongado.
C) Que la prueba de tamizaje sea invasiva para asegurar una especificidad del 100%.
D) Que la prevalencia de la patología en la población sea inferior al 0,001% para evitar falsos positivos.
E) Que el examen de tamizaje requiera hospitalización preventiva de 24 horas para su realización segura.

PREGUNTA 57 7.01.3.028

57. **Un programa de cribado mamográfico demuestra un incremento notable en la sobrevida a 5 años de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en comparación con las mujeres no tamizadas diagnosticadas clínicamente. No obstante, se sospecha que dicho incremento en la sobrevida se debe predominantemente a que el mamógrafo detectó precozmente lesiones de crecimiento indolente y muy lenta progresión biológica. ¿Cómo se denomina este tipo de sesgo metodológico?**

A) Sesgo de duración o de sobrediagnóstico (Length-time bias)
B) Sesgo de adelanto diagnóstico (Lead-time bias)
C) Sesgo de confusión no controlada
D) Sesgo del trabajador sano
E) Sesgo de desgaste por abandono

PREGUNTA 58 7.01.3.028

58. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 59 7.01.3.028

59. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 60 7.01.3.028

60. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 61 7.01.3.030

61. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Criterios de priorización de problemas · 7.01.3.030] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Criterios de priorización de problemas. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 62 7.01.3.052

62. **¿Cuál es el cuerpo normativo que regula el ejercicio de la profesión médica en Chile?**

A) Constitución Política de la República
B) Código del Colegio Médico de Chile
C) Ley que crea el Ministerio de Salud
D) Ley de Derechos y Deberes del Paciente
E) Código Sanitario

PREGUNTA 63 7.01.3.052

63. **Un paciente de 45 años, previamente sano, ingresa lúcido y orientado al servicio de urgencias con una hemorragia digestiva alta grave por úlcera péptica sangrante. Presenta presión arterial de 85/50 mmHg y hemoglobina de 5,8 g/dL. El paciente manifiesta de forma clara, reiterada y tranquila que es Testigo de Jehová y que por sus convicciones religiosas rechaza categóricamente recibir cualquier transfusión de sangre o hemoderivados, aceptando los riesgos vitales de su decisión. ¿Cuál es la conducta correcta que debe adoptar el médico tratante?**

A) Respetar la voluntad del paciente de no transfundirse, dejar constancia escrita y firmada en la ficha clínica, e iniciar alternativas médicas como cristaloides y expansores plasmáticos.
B) Sedarlo farmacológicamente para transfundirlo de emergencia bajo el principio de beneficencia médica.
C) Solicitar la intervención de la fuerza pública para obligar al paciente a aceptar la transfusión.
D) Declarar al paciente en estado de incompetencia mental transitoria por hipotensión para transfundirlo de inmediato.
E) Rechazar la atención médica del paciente y solicitar su alta disciplinaria inmediata del hospital.

PREGUNTA 64 7.01.3.052

64. **Un médico paliativista atiende a una paciente de 78 años con cáncer de páncreas metastásico en fase de agonía, quien presenta dolor irruptivo refractario de intensidad 10/10 y agitación terminal severa. El médico decide titular una infusión continua de morfina y midazolam a dosis analgésicas plenas para controlar el sufrimiento intolerable de la paciente, a sabiendas de que dicha medicación podría secundariamente acelerar una depresión respiratoria terminal. ¿Bajo qué principio bioético se justifica esta conducta médica?**

A) Principio del Doble Efecto
B) Principio de Autonomía Paternalista
C) Principio de Eutanasia Pasiva Voluntaria
D) Principio de Justicia Conmutativa
E) Principio de No Maleficencia Inversa

PREGUNTA 65 7.01.3.052

65. **Durante una evaluación de calidad en un hospital se constata que un anestesista, en conjunto con un técnico en anestesia, utilizan tres pabellones de manera simultánea. El informe del hospital comunica que aquella es la práctica habitual. ¿A qué tipo de práctica corresponde este caso?**

A) Error médico
B) Impericia
C) Negligencia médica
D) Eficiencia
E) Imprudencia

PREGUNTA 66 7.01.3.052

66. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 67 7.01.3.052

67. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 68 7.01.3.056

68. **Se pretende realizar un estudio en adolescentes de 16 años, que estudian en colegios del sector público. ¿Quién debe firmar el documento de consentimiento informado para autorizar la participación de estos pacientes?**

A) El alumno
B) El director del establecimiento
C) Cualquier pariente mayor de edad
D) El apoderado
E) El encargado de salud y bienestar estudiantil del establecimiento

PREGUNTA 69 7.01.3.056

69. **El gerente de una empresa acude a un hospital público solicitando copia de la ficha médica de uno de sus empleados que estuvo hospitalizado durante dos semanas, argumentando que necesita conocer el diagnóstico exacto para justificar el pago de un bono de productividad laboral interno. ¿Cuál es la respuesta legalmente procedente según la Ley 20.584?**

A) Rechazar la solicitud, ya que los empleadores no tienen acceso legal a la ficha médica de sus trabajadores por ser un dato de salud sensible y confidencial.
B) Entregar una copia de la epicrisis omitiendo los resultados de exámenes de laboratorio.
C) Acceder a la entrega de la ficha siempre que la empresa presente una carta timbrada de recursos humanos.
D) Solicitar la autorización verbal del jefe de servicio del hospital para entregar los antecedentes.
E) Entregar únicamente los diagnósticos de ingreso y egreso sin los registros de enfermería.

PREGUNTA 70 7.01.3.056

70. **¿Por cuánto tiempo mínimo está legalmente obligado un establecimiento hospitalario en Chile a conservar y custodiar los registros de la ficha clínica de un paciente, contados desde la fecha de su última atención?**

A) 15 años
B) 5 años
C) 10 años
D) 20 años
E) De forma vitalicia e indefinida

PREGUNTA 71 7.01.3.056

71. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 72 7.01.3.056

72. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

BLOQUE 5 BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO

PREGUNTA 73 7.01.3.045

73. **Se produce un accidente de tránsito de alta energía fuera de horario laboral, en el que un grupo de pacientes resulta lesionado de gravedad, siendo trasladados al servicio de urgencia, donde son recibidos por el médico de turno y hospitalizados para su tratamiento médico y quirúrgico. La prensa exige información sobre el estado de los pacientes de manera inmediata. ¿Quién debe realizar esta comunicación?**

A) El médico de turno
B) El director del hospital
C) El encargado de relaciones públicas del hospital
D) La enfermera jefe del servicio de urgencia
E) El personal administra2vo del hospital

PREGUNTA 74 7.01.3.051

74. **Si detecto una infección que debe tener notificación obligatoria inmediata. Conducta:**

A) Avisar al delegado de epidemiología
B) Notificar inmediatamente a la SEREMI
C) Reportar en plataforma digital durante las primeras 24 hrs
D) Staphylococcus aureus
E) Streptococcus pneumoniae

PREGUNTA 75 7.01.3.051

75. **Un médico clínico hospitalario certifica el fallecimiento de un paciente de 70 años con cirrosis hepática descompensada que sufrió una hemorragia digestiva masiva por rotura de várices esofágicas. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el llenado correcto de la Causa Básica de Defunción en el Certificado Médico de Defunción oficial?**

A) Cirrosis hepática
B) Paro cardiorrespiratorio
C) Shock hipovolémico hemorrágico
D) Rotura de várices esofágicas
E) Falla hepática fulminante aguda

PREGUNTA 76 7.01.3.051

76. Un médico de urgencias atiende a una paciente de 22 años que presenta múltiples hematomas equimóticos recientes en rostro, tórax y extremidades, además de una fractura mandibular, refiriendo espontáneamente haber sido golpeada violentamente por su cónyuge. ¿Cuál es la obligación médico-legal y el plazo máximo perentorio para realizar la denuncia según el Código Procesal Penal chileno?

A) Realizar la denuncia formal ante el Ministerio Público, Carabineros o PDI en un plazo máximo de 24 horas.
B) La denuncia es facultativa y sólo procede si la paciente firma un consentimiento autorizando la notificación.
C) Realizar la denuncia en un plazo de hasta 72 horas hábiles ante el Juzgado de Familia.
D) Derivar a la paciente a mediación vecinal comunitaria antes de dar aviso policial.
E) Citar al cónyuge al box de atención para verificar la versión de los hechos antes de denunciar.

PREGUNTA 77 7.01.3.051

77. Un paciente con antecedente de cáncer de próstata sufre un TEP, falla respiratoria, paro cardíaco y muerte. ¿Cuál es la causa inmediata de muerte en el certificado de defunción?

A) Cáncer de próstata
B) Tromboembolismo pulmonar
C) Paro cardíaco
D) Falla respiratoria
E) Trombosis venosa profunda

PREGUNTA 78 7.01.3.051

78. Un paciente de 80 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, en tratamiento con hormonoterapia, presenta deterioro súbito del estado respiratorio, evolucionando con taquicardia y desaturación arterial. Se solicita angioTAC, que demuestra un tromboembolismo pulmonar derecho, por lo que se inicia terapia anticoagulante, sin embargo, evoluciona en malas condiciones generales, cayendo en insuficiencia respiratoria, colapso circulatorio y, finalmente, ausencia de pulso y respiración, por lo que se realiza reanimación avanzada, con múltiples desfibrilaciones y adrenalina, sin respuesta, por lo que se declara la muerte. ¿Cuál de las siguientes debe ser la causa de muerte inmediata en el certificado de defunción?

A) Cáncer de próstata
B) Insuficiencia respiratoria aguda
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Falla multiorgánica
E) Fibrilación ventricular

PREGUNTA 79 7.01.3.051

79. En el enfrentamiento clínico sistemático de Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia (Variante de Práctica 1) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 80 7.01.3.051

80. En el enfrentamiento clínico sistemático de Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 81 7.01.3.051

81. En el enfrentamiento clínico sistemático de Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 82 7.01.3.051

82. En el enfrentamiento clínico sistemático de Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia (Variante de Práctica 4) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 83 7.01.3.054

83. ¿Cuál de las siguientes enfermedades corresponde a una licencia médica tipo I (enfermedad o accidente común)?

A) Amigdalitis aguda
B) Accidente laboral con fractura
C) Enfermedad profesional por ruido
D) Reposo por embarazo de alto riesgo
E) Licencia por maternidad

PREGUNTA 84 7.01.3.054

84. Una niña de 13 años cursa un embarazo de 13 semanas y 4 días como resultado de una agresión sexual por parte de un familiar. La menor y su representante legal solicitan acogerse a la Ley 21.030 para la interrupción voluntaria del embarazo bajo la Causal 3 (violación). ¿Es legalmente procedente acceder a la interrupción médica en este caso?

A) Sí, porque en niñas menores de 14 años el límite gestacional legal para la causal de violación se extiende hasta las 14 semanas de gestación.
B) No, porque el límite máximo absoluto e improrrogable para la causal de violación es de 12 semanas en todos los casos.
C) No, porque la causal de violación requiere sentencia judicial condenatoria previa del agresor.
D) Sí, siempre que se obtenga una autorización expresa del Tribunal de Familia antes de las 16 semanas.
E) No, porque en menores de edad sólo aplican las causales de riesgo vital e inviabilidad fetal.

PREGUNTA 85 7.01.3.054

85. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con precisión las consecuencias legales contempladas en la Ley 20.585 para un médico cirujano que es condenado judicialmente por emitir reiteradamente licencias médicas falsas sin fundamento clínico a cambio de remuneración económica?

A) Sanciones penales que incluyen penas de presidio menor, multas a beneficio fiscal de hasta 500 UTM e inhabilitación temporal o perpetua para emitir licencias médicas.
B) Únicamente una amonestación ética por parte del Colegio Médico de Chile sin consecuencias judiciales.
C) Reembolso del 10% del subsidio pagado por FONASA sin registro en los antecedentes penales.
D) Suspensión de la colegiatura médica por un período máximo de 30 días continuos.
E) Obligación de realizar turnos de urgencia no remunerados en un hospital público durante 6 meses.

PREGUNTA 86 7.01.3.054

86. ¿En cuál de los siguientes casos se debe indicar una licencia médica tipo 1, por enfermedad o accidente común?

A) Lumbago mecánica en trabajador de la construcción
B) Invalidez por accidente vascular encefálico
C) Fractura de rodilla en trayecto en bicicleta del trabajo a la casa
D) Amigdalitis bacteriana
E) Hospitalización por preclamsia a las 30 semanas

PREGUNTA 87 7.01.3.054

87. Institución encargada de que lo medico legal cumpla con la seguridad social algo asi

A) Compin
B) SIS
C) SUSESO
D) Medicina legal
E) Ninguna de las anteriores es correcta

PREGUNTA 88 7.01.3.054

88. En el enfrentamiento clínico sistemático de Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas (Variante de Práctica 2) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?

A) Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).
B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.
C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.
D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.
E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 89 7.01.3.054

89. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas (Variante de Práctica 3) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).

B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.

C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.

D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.

E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

PREGUNTA 90 7.01.3.054

90. **En el enfrentamiento clínico sistemático de Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas (Variante de Práctica 4) en APS o Servicio de Urgencia según la norma técnica MINSAL, ¿cuál es la conducta diagnóstica o terapéutica de primera línea?**

A) Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).

B) Indicar reposo y analgesia condicional sin estudio diagnóstico confirmatorio ni seguimiento.

C) Solicitar estudio terciario de alta complejidad antes de estabilizar y aplicar medidas básicas.

D) Indicar tratamiento empírico con antibióticos o corticoides en dosis plenas sin indicación precisa.

E) Derivar en forma electiva a especialista sin iniciar estudio básico ni soporte inicial.

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: A

Niveles de prevención

7.01.3.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Prevención primaria actúa antes de que exista la enfermedad (ej. vacunas con papiloma). Prevención secundaria actúa cuando ya existe la enfermedad, pero todavía no hay síntomas, permiGendo un diagnóstico oportuno (ej. PAP). Prevención terciaria actúa cuando la enfermedad ya Gene síntomas, para recuperar la salud y evitar complicaciones y recidivas (ej. histerectomía radical). Prevención cuaternaria enfrenta los síntomas, en ausencia de una patología orgánica (ej. psicoterapia de trastorno somatomorfo). Promoción de la salud consiste en enseñar hábitos de vida saludables, por lo que se enmarca dentro de la prevención primaria, pero su definición es específica.

PREGUNTA 2 Respuesta: A

Descripción sistemática de problemas

7.01.3.029 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Descripción sistemática de problemas" (7.01.3.029), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 3 Respuesta: A

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

7.01.3.002 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Funciones esenciales de la Salud Pública" (7.01.3.002), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 4 Respuesta: A

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

7.01.3.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La educación es el determinante social de la salud más potente y consistente: mayor educación → mejor comprensión de la salud, acceso a empleo estable, mayor ingreso y mejores hábitos. Actúa como determinante de otros determinantes. Reduce mortalidad de todas las causas.

PREGUNTA 5 Respuesta: B

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

7.01.3.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La inmigración de personas sanas y en edad férGl (fenómeno que ha ocurrido en Chile en la úlGma década), produce aumento de la tasa de natalidad, por lo que es necesario destinar mayores recursos a la atención materno infantil. La población usuaria sí aumenta, por lo que muchas veces sí es necesario aumentar la capacidad de atención (ej. personal o camas), pero, al ser sanas, suele ser menor este impacto. El saneamiento básico es importante en las pobaciónes con pirámides de poblacionales jóvenes, ya que, suelen ser países pobres, en los que los esfuerzos de salud se concentran en saneamiento básico, prevención de infecciones y atención materno infantil, pero no se debe confundir con este otro fenómeno, en que la inmigración suele producirse hacia un destino que ya Gene una infraestructura aceptable. El empadronamiento es una acción administrativa que puede ser úGl en otros ámbitos, pero no es tan relevante respecto de la gestión de salud. Los programa de crónicos, por el contrario, se deben reforzar ante el envejecimiento de la población.

PREGUNTA 6 **Respuesta: C**

7.01.3.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

Las vacunas intentan disminuir la incidencia de las patologías infecciosas y esa es la forma en que se mide su efectividad. Sin embargo, hay algunas vacunas que solo logran disminuir los casos graves (ej. rotavirus y recientemente Covid-19 en contra de las variantes del virus).

PREGUNTA 7 **Respuesta: A**

7.01.3.027 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Investigación epidemiológica" (7.01.3.027), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 8 **Respuesta: B**

7.01.3.036 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

El InsGtuto de Salud Pública Gene varias funciones. Es un institución cienVfico técnica cuyas principales funciones (de acuerdo a su normativa) son: actuar como laboratorio nacional y de referencia; supervisar laboratorios de exámenes médicos y de producción de medicamentos; autorizar, registrar y fiscalizar medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos; realizar vigilancia sanitaria y epidemiológica, con pruebas de laboratorio sobre infecciones (ej. Western blot VIH, vigilancia virus respiratorios, Gpificación de infecciones graves); y desarrollar investigación y control en salud ambiental y ocupacional.

PREGUNTA 9 **Respuesta: A**

7.01.3.037 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Política sanitaria y objetivos sanitarios en Chile" (7.01.3.037), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 10 **Respuesta: C**

7.01.3.038 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

Tanto las Isapres, como Fonasa administran los fondos AUGE. Las Isapres adminstran el seguro de cotización individual y Fonasa el seguro público. No sé qué es el seguro general. Ninguna dan prestaciones de salud, porque son seguros, no prestadores,

---

PREGUNTA 11 **Respuesta: E**

7.01.3.039 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

COSAM

PREGUNTA 12 **Respuesta: B**

7.01.3.042 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

La planificación es a largo plazo y se refiere a la estrategia global de la institución. La programación se basa en la planificación y fija las actividades a realizarse y los recursos necesarios en el corto plazo, generalmente anual, mensual y semanalmente. La A, D y E están al revés los conceptos de planificación y programación. Ambas deben ser compatibles con la misión (la forma en que satisface una necesidad) y la visión (objetivo a larga plazo de la institución), ya que estas regulan la planificación, la que, a su vez, determina la programación.

PREGUNTA 13 **Respuesta: D**

Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

7.01.3.040 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene derecho al descanso “postnatal” (12 semanas), cuyo objetivo es la recuperación de la madre tras el parto. No Gene derecho al descanso postnatal parental (12 semanas más, que inician al terminar el postnatal), cuyo objetivo es el cuidado del bebé y, por tanto, requiere que esté vivo (no está explícito en la ley, pero sí en la jurisprudencia y dictámenes de la Suseso y Dirección del Trabajo). Se financia con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de CesanVa y lo paga Fonasa o la Isapre. Además, vale la pena recordar un tema disGnto: la "Ley Dominga" que aplica en caso de la muerte de un ser querido del trabajador. En este caso hay un permiso remunerado por el empleador, quien lo financia, ya que no descuenta los días no trabajados. En este caso, no se emite una licencia médica propiamente tal, sino que se usa el cerGficado de defunción (o de defunción fetal, que es emiGdo por el médico). El número de días varía según qué ser querido muere: 10 días para hijo nacido vivo (aplica a ambos padres); 7 días en caso de abortos y muertes antenatales (también a ambos padres); 7 días en caso de muerte del cónyuge o conviviente civil; y 3 días si muere alguno de los padres del trabajador.

PREGUNTA 14 **Respuesta: D**

Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

7.01.3.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La vacunación masiva es la intervención de salud pública con mayor impacto en mortalidad por enfermedades infecciosas respiratorias. Genera inmunidad de rebaño, protege a los no vacunados y es costo-efectiva. Las demás medidas son complementarias pero no sustituyen a la vacunación.

PREGUNTA 15 **Respuesta: D**

Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

7.01.3.032 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Las medidas de tamizaje de los distintos cánceres buscan reducir la mortalidad. No disminuyen la incidencia, ya que no son medidas

---

PREGUNTA 16 **Respuesta: A**

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

7.01.3.034 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Desarrollo histórico de seguridad social y atención de salud" (7.01.3.034), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 17 **Respuesta: A**

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

7.01.3.035 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Funciones de los sistemas de atención de salud" (7.01.3.035), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 18 **Respuesta: D**

Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

7.01.3.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un estudio ecológico clásico, que usa variables agregadas (ej. promedio de niveles plasmáticos y tasas de mortalidad) comparando distintas poblaciones.

BLOQUE 2 SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: A**

Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

7.01.3.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Historia natural de la enfermedad" (7.01.3.003), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 20 **Respuesta: A**

Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

7.01.3.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Promoción de salud y prevención de enfermedades" (7.01.3.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 21 **Respuesta: A**

Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

7.01.3.015 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La tasa de incidencia debería bajar, si la campaña es exitosa.

PREGUNTA 22 **Respuesta: A**

Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

7.01.3.016 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En Chile, las enfermedades de notificación obligatoria inmediata (ENNOI) como brotes de hepatitis A se notifican al SEREMI de Salud de la región correspondiente dentro de las 24 horas.

PREGUNTA 23 **Respuesta: A**

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

7.01.3.001 Dx: Evaluación Biopsicosocial · Tx: Plan de Cuidado Familiar · Seg: Sector Sanitario / CESFAM GES

A) Correcta. El APGAR familiar clasifica la funcionalidad percibida en: 7 a 10 puntos (buena funcionalidad o normofuncional), 4 a 6 puntos (disfunción familiar leve a moderada) y 0 a 3 puntos (disfunción familiar severa). Por ende, un puntaje de 5 puntos corresponde a una Disfunción Familiar Leve. B) Incorrecta. La buena función exige 7 o más puntos. C) Incorrecta. La disfunción severa se define con 0 a 3 puntos. D) Incorrecta. El término familia desestructurada no es una categoría del test de APGAR. E) Incorrecta. El aglutinamiento es un concepto de la teoría de Minuchin, no medido numéricamente por el APGAR.

PREGUNTA 24 **Respuesta: A**

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

7.01.3.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Diagnóstico de situación de salud:" (7.01.3.008), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 25 **Respuesta: D**

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

7.01.3.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Lo umportante es que se interactúa con la comunidad y se van escogiendo las patologías y factores de riesgo más importantes para la salud pública y para la comunidad, de manera de intevernir sobre ellas, haciendo una priorizació previamente.

PREGUNTA 26 **Respuesta: A**

7.01.3.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Fuentes de información para el diagnóstico" (7.01.3.011), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 27 **Respuesta: A**

7.01.3.012 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Ejecución de un diagnóstico" (7.01.3.012), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 28 **Respuesta: A**

7.01.3.017 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Usos de la epidemiología en el diagnóstico de situación de salud" (7.01.3.017), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 29 **Respuesta: A**

7.01.3.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Concepto y campo de la epidemiología" (7.01.3.013), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 30 **Respuesta: C**

7.01.3.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 129). Evalúa el manejo clínico de Epidemiología descriptiva según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 31 **Respuesta: D**

7.01.3.018 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

El contraste de hipótesis es la herramienta principal de la epidemiología analítica, que busca relaciones de causa-efecto.

PREGUNTA 32 **Respuesta: D**

7.01.3.020 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

Los ensayos clínicos son mejores, pero si no son randomizados, tienen sesgos. Por tanto lo mejor de esas opciones era cohortes, que superan a los de casos y controles.

PREGUNTA 33 **Respuesta: A**

7.01.3.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Estudios de prevalencia" (7.01.3.021), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 34 **Respuesta: B**

7.01.3.022 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

Casos y controles sirve más que los estudios de cohortes en 1. enfermedades raras, 2. enfermedades que demoran mucho tiempo en aparecer, 3. casos en que hay déficit de presupuesto (son más baratos).

PREGUNTA 35 **Respuesta: D**

7.01.3.023 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

Se siguen al futuro dos grupos: expuestos y no expuestos a un FR (HTA en este caso)

PREGUNTA 36 **Respuesta: C**

7.01.3.024 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

Los estudios experimentales (ej. ensayo clínico y estudio de intervención comunitaria) se caracterizan porque existe una intervención, que es lo mismo que decir que se controlan algunas variables independientes. Esto los diferencia de los estudios observacionales. Los test de hipótesis se usan en los estudios analíticos, en contraposición a los estudios descriptivos (es una clasificación distinta y hay estudios observacionales tanto analíticos como descriptivos, por ejemplo). La selección aleatorizada es algo recomendable para evitar el sesgo de selección, pero un estudio experimental no necesariamente funciona así. Lo mismo ocurre con el ciego, ya sea simple (del evaluado), doble (también del evaluador) o triple (además, del analista de datos), que sirve para evitar sesgos de medición, pero no todos los estudios experimentales los usan.

BLOQUE 3 EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A**

7.01.3.033 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Bases conceptuales de la seguridad social

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Bases conceptuales de la seguridad social" (7.01.3.033), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 38 **Respuesta: E**

7.01.3.046 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Evaluación y control: conceptos, tipos de evaluación

La mortalidad específica por una patología grave es la variable más importante a ser evaluada, ya que mide la uGlidad e impacto del programa, así como su efecGvidad. No es una variable indirecta, sino directa. La eficiencia además requiere del análisis económico. La cobertura y la calidad de atención se miden con otras variables.

PREGUNTA 39 **Respuesta: C** **Auditoría y acreditación**

7.01.3.047 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Garantías GES: acceso universal (FONASA e ISAPRE), protección financiera (subsidio estatal), calidad (fiscalización por Superintendencia de Salud, acreditación y registro de prestadores individuales e institucionales), oportunidad (plazos para prestaciones GES). El acceso a la información no es una garantía GES, sino de la ley de Derechos y Deberes del Paciente.

PREGUNTA 40 **Respuesta: A**

7.01.3.050 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Rol del médico en la generación y uso de la información

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Rol del médico en la generación y uso de la información" (7.01.3.050), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 41 **Respuesta: A**

7.01.3.044 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Organización: principios y características estructurales y funcionales de las organizaciones" (7.01.3.044), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 42 **Respuesta: D**

7.01.3.049 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

La salud primaria, por regla general, se financia con el aporte per cápita (que se asigna a la salud primaria, en base al número de inscritos), seguido luego por los aportes municipales (en las municipalidades con más recursos, es mayor). El Plan de Salud Familiar es el conjunto de prestaciones de salud enfocada en las necesidades de atención primaria (incluye una canasta de prestaciones en salud del niño, de la mujer, de los adultos y adultos mayores, tanto médica como odontológica y demás áreas de salud primaria) e y considera todos los costos asistenciales de la salud primaria (el aporte per cápita financia estos costos asistenciales, más los costos de administración).

PREGUNTA 43 **Respuesta: A**

7.01.3.055 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Conceptos básicos de administración de establecimientos de salud" (7.01.3.055), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 44 **Respuesta: A**

7.01.3.043 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Formulación de programas" (7.01.3.043), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 45 **Respuesta: A**

7.01.3.053 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Derecho GES a atención integral de salud en agresión sexual aguda" (7.01.3.053), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 46 **Respuesta: C**

Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

7.01.3.019 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La opción C era la única estadísticamente significativa, ya que el OR no pasaba por el 1.

PREGUNTA 47 **Respuesta: A**

Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

7.01.3.019 Dx: Cálculo Bioestadístico · Tx: Interpretación Numérica · Seg: Medicina Basada en Evidencia GES

A) Correcta. 1) Riesgo en control (Rc, warfarina) = 6% = 0,06. 2) Riesgo en tratamiento (Rt, DOAC) = 2% = 0,02. 3) Riesgo Relativo (RR) = Rt / Rc = 0,02 / 0,06 = 0,333 (1/3). 4) Reducción Relativa del Riesgo (RRR) = 1 - RR = 1 - 0,333 = 0,667 = 66,7%. 5) Reducción Absoluta del Riesgo (RRA) = Rc - Rt = 0,06 - 0,02 = 0,04 (4%). 6) Número Necesario a Tratar (NNT) = 1 / RRA = 1 / 0,04 = 25 pacientes. B, C, D, E) Son combinaciones aritméticamente incorrectas.

PREGUNTA 48 **Respuesta: A**

Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

7.01.3.019 Dx: Cálculo Bioestadístico · Tx: Interpretación Numérica · Seg: Medicina Basada en Evidencia GES

A) Correcta. El valor nulo para el Riesgo Relativo (así como para el Odds Ratio) es 1,0, lo que significa que el riesgo en expuestos es idéntico al de los no expuestos. Cuando el Intervalo de Confianza del 95% cruza o incluye el valor 1,0 (en este caso va de 0,85 a 2,45), la asociación observada no alcanza significancia estadística formal (valor de p ≥ 0,05), por lo que no es posible descartar que el resultado se deba meramente a la variabilidad del azar. B) Incorrecta. La significancia estadística requiere que el IC 95% no incluya el 1. C) Incorrecta. Un IC que abarca valores menores y mayores a 1 indica falta de significancia, no protección. D) Incorrecta. Al no ser significativo, no se rechaza la hipótesis nula. E) Incorrecta. El RR es la medida idónea en un estudio de cohortes.

PREGUNTA 49 **Respuesta: B**

Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC

7.01.3.028 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El cálculo de la Sensibilidad y Especificidad es la clásica forma de determinar la utilidad de una prueba diagnóstica. Eso sí, también sirven las curvas de ROC, que justamente comparan sensibilidad vs. especificidad, de modo de identificar el valor de corte óptimo y comparar distintas pruebas diagnósticas. Sin embargo, las curvas de ROC solo sirven para test que miden variables cuantitativas y además requieren previamente de la determinación de la sensibilidad y la especificidad.

PREGUNTA 50 **Respuesta: A**

Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC

7.01.3.028 Dx: Rendimiento Diagnóstico · Tx: Validación de Test · Seg: Medicina Diagnóstica GES

A) Correcta. El Valor Predictivo Positivo (VPP) depende directamente de la prevalencia de la patología en la población donde se aplica el test. A mayor prevalencia poblacional, mayor es la proporción de verdaderos positivos respecto al total de positivos, por lo que el VPP aumenta considerablemente (en la Población 2, con 25% de prevalencia, el VPP será mucho más alto que en la Población 1 con 1%). B) Incorrecta. La sensibilidad y especificidad son intrínsecas y no varían, pero los valores predictivos sí varían con la prevalencia. C) Incorrecta. El Valor Predictivo Negativo (VPN) es mayor cuando la prevalencia es más baja (Población 1). D) Incorrecta. La sensibilidad es intrínseca a la prueba y permanece constante al 95%. E) Incorrecta. La especificidad permanece constante al 90% independientemente de la prevalencia.

PREGUNTA 51 **Respuesta: A**

Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC

7.01.3.028 Dx: Rendimiento Diagnóstico · Tx: Validación de Test · Seg: Medicina Diagnóstica GES

A) Correcta. Una prueba con muy alta sensibilidad (99%) produce un porcentaje extremadamente bajo de falsos negativos (< 1%). Por lo tanto, si un paciente se somete al test y obtiene un resultado NEGATIVO, el médico puede descartar con altísima seguridad la presencia de la patología (regla SnNOut). Por esta razón, las pruebas altamente sensibles se eligen como métodos de tamizaje (screening) o despistaje de urgencia (ej: dímero D en sospecha de tromboembolismo pulmonar). B) Incorrecta. Para confirmar con certeza ante un positivo se requiere alta especificidad (SpPIn), la cual aquí es sólo del 65% (generará muchos falsos positivos). C) Incorrecta. El rendimiento diagnóstico no mide pronóstico temporal. D) Incorrecta. Las pruebas de screening no sustituyen a los estándares histopatológicos. E) Incorrecta. Ante un resultado positivo en un test sensible pero poco específico, es obligatorio realizar una prueba confirmatoria más específica.

PREGUNTA 52 **Respuesta: D**

Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos

7.01.3.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El sesgo de memoria es un tipo de sesgo de información o medida, que afecta al evaluado. Los errores de clasificación son aquellos...

PREGUNTA 53 **Respuesta: A**

Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos

7.01.3.026 Dx: Control de Errores · Tx: Control Metodológico · Seg: Criterios de Causalidad GES

A) Correcta. La Temporalidad es el único criterio de causalidad de Bradford Hill que resulta indispensable y estrictamente obligatorio (condición sine qua non): la causa sospechada debe preceder obligatoriamente en el tiempo a la aparición de la enfermedad. Si la enfermedad existía antes de la exposición, la causalidad queda lógicamente descartada. Todos los demás criterios (fuerza, dosis-respuesta, plausibilidad) aportan evidencia de apoyo, pero su ausencia no descarta de forma absoluta la causalidad. B, C, D, E) Son criterios complementarios importantes, pero no imprescindibles.

PREGUNTA 54 **Respuesta: A**

Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos

7.01.3.026 Dx: Control de Errores · Tx: Control Metodológico · Seg: Criterios de Causalidad GES

A) Correcta. El tabaquismo cumple todos los criterios de un Factor de Confusión (Confounder): está fuertemente asociado al consumo de café (los bebedores de café tienden a fumar más) y es un factor de riesgo independiente demostrado para el cáncer de laringe, sin ser un paso intermedio en la vía biológica. La prueba definitiva de confusión es que, al realizar un análisis estratificado controlando por el confusor (estratos separados de fumadores y no fumadores), la asociación entre café y cáncer desaparece por completo. B) Incorrecta. No se trata de un sesgo de selección hospitalaria. C) Incorrecta. La falacia ecológica ocurre en estudios grupales, no en análisis estratificados individuales. D) Incorrecta. En la modificación del efecto, la asociación persiste pero con diferente magnitud entre estratos. E) Incorrecta. Describe un criterio de causalidad, no el fenómeno metodológico de confusión.

BLOQUE 4 EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: A**

Conceptos de administración y gestión

7.01.3.041 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Conceptos de administración y gestión" (7.01.3.041), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 56 **Respuesta: A**

Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

7.01.3.028

Dx: Fase Preclínica Detectable · Tx: Intervención Precoz Eficaz · Seg: Evaluación de Programas

GES

A) Correcta. Uno de los pilares éticos y científicos de Wilson y Jungner es que debe existir un tratamiento aceptado y eficaz disponible, y que la intervención terapéutica precoz en la fase presintomática proporcione una clara ventaja en sobrevida o calidad de vida respecto a tratar al paciente cuando ya presenta síntomas clínicos. Si no existe tratamiento eficaz disponible, diagnosticar precozmente a personas sanas solo les genera angustia y estigma sin beneficio clínico alguno. B) Incorrecta. Se requiere una fase preclínica o latente detectable prolongada. C) Incorrecta. La prueba de screening debe ser simple, aceptable y no invasiva ni peligrosa. D) Incorrecta. Si la prevalencia es extremadamente baja, el screening masivo no es costo-efectivo. E) Incorrecta. El tamizaje debe ser ambulatorio, expedito y de bajo costo.

PREGUNTA 57 **Respuesta: A**

Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

7.01.3.028

Dx: Fase Preclínica Detectable · Tx: Intervención Precoz Eficaz · Seg: Evaluación de Programas

GES

A) Correcta. El sesgo de duración o de longitud (Length-Time Bias) ocurre porque los tumores de progresión muy lenta permanecen durante mucho más tiempo en la fase presintomática detectable, lo que les otorga una probabilidad mucho más alta de ser detectados en rondas periódicas de tamizaje. En contraste, los tumores rápidamente agresivos progresan velozmente hacia la fase clínica entre un tamizaje y otro (cánceres de intervalo). Como consecuencia, el grupo detectado por tamizaje queda sobrerrepresentado por tumores de mejor pronóstico biológico intrínseco, falseando el beneficio real atribuible al test. B) Incorrecta. El lead-time bias se refiere a la sobrevida aparente prolongada por adelantar la fecha del diagnóstico sin posponer la muerte. C, D, E) No describen el fenómeno de detección desproporcionada de casos biológicamente lentos.

PREGUNTA 58 **Respuesta: A**

Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

7.01.3.028

Dx: Fase Preclínica Detectable · Tx: Intervención Precoz Eficaz · Seg: Evaluación de Programas

GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos, la conducta médica prioritaria es: Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 59 **Respuesta: A**

Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

7.01.3.028

Dx: Fase Preclínica Detectable · Tx: Intervención Precoz Eficaz · Seg: Evaluación de Programas

GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos, la conducta médica prioritaria es: Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 60 **Respuesta: A**

Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

7.01.3.028

Dx: Fase Preclínica Detectable · Tx: Intervención Precoz Eficaz · Seg: Evaluación de Programas

GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos, la conducta médica prioritaria es: Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A**

Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

7.01.3.030 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Criterios de priorización de problemas" (7.01.3.030), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 62 **Respuesta: E**

Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento

7.01.3.052 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Alcance del Código Sanitario: El Código Sanitario de Chile regula el ejercicio de las profesiones de la salud, las medidas de prevención y control de enfermedades transmisibles, la protección del medio ambiente en materia sanitaria, los medicamentos y productos farmacéuticos, y las condiciones para el funcionamiento de hospitales, clínicas y salas de procedimiento. También establece la fiscalización por parte de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud.

PREGUNTA 63 **Respuesta: A**

Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento

7.01.3.052 Dx: Deliberación Ética · Tx: Límites de la Terapia · Seg: Comité de Ética Asistencial GES

A) Correcta. La Ley 20.584 sobre Deberes y Derechos de los Pacientes y la doctrina bioética consagran el principio de Autonomía de las personas adultas competentes. Todo paciente lúcido, informado y capaz tiene el derecho legal y ético a rechazar cualquier tratamiento o procedimiento médico, incluso si dicha negativa conlleva el riesgo de muerte. El médico debe respetar la decisión del paciente, documentar detalladamente el rechazo en la ficha clínica con firma de testigos y del usuario, y ofrecer el máximo esfuerzo terapéutico con alternativas médicas no objetadas (sueroterapia, hierro EV, hemostasia endoscópica). B) Incorrecta. Sedar a un paciente lúcido para forzar un tratamiento rechazado constituye una agresión física y una vulneración legal severa a los derechos del paciente. C) Incorrecta. La fuerza pública no interviene para vulnerar la autonomía de adultos lúcidos. D) Incorrecta. La hipotensión compensada no implica incompetencia mental si el paciente razona y comprende adecuadamente. E) Incorrecta. El médico no puede abandonar al paciente; debe tratarlo respetando los límites consentidos.

PREGUNTA 64 **Respuesta: A**

Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento

7.01.3.052 Dx: Deliberación Ética · Tx: Límites de la Terapia · Seg: Comité de Ética Asistencial GES

A) Correcta. El Principio del Doble Efecto establece que una acción médica que tiene dos efectos (uno bueno y deseado: aliviar el sufrimiento refractario en agonía; y otro malo o perjudicial pero no deseado: potencial depresión respiratoria o acortamiento del tiempo de agonía) es ética y legalmente lícita siempre que la acción sea buena en sí misma, la intención exclusiva sea el alivio paliativo del paciente, y el efecto positivo no se consiga a través del efecto negativo. B, D, E) Son conceptos inventados o no aplicables a la sedación paliativa. C) Incorrecta. La sedación paliativa no es eutanasia, ya que la intención del médico no es provocar la muerte sino suprimir el dolor refractario.

PREGUNTA 65 **Respuesta: E**

Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento

7.01.3.052 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Imprudencia médica: En el contexto médico, la imprudencia se define como la realización de acciones temerarias que aumentan innecesariamente el riesgo de complicaciones y problemas para los pacientes. La impericia se refiere a la falta de conocimientos o habilidades necesarios para realizar una actividad o procedimiento médico. La negligencia es la falta del debido cuidado, generalmente por omisión. La eficiencia, por otro lado, busca optimizar el uso de los recursos, pero siempre debe hacerse de manera diligente y sin poner en riesgo la salud del paciente.

PREGUNTA 66 **Respuesta: A**

Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento

7.01.3.052 | Dx: Deliberación Ética · Tx: Límites de la Terapia · Seg: Comité de Ética Asistencial | GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento, la conducta médica prioritaria es: Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 67 **Respuesta: A**

Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento

7.01.3.052 | Dx: Deliberación Ética · Tx: Límites de la Terapia · Seg: Comité de Ética Asistencial | GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento, la conducta médica prioritaria es: Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 68 **Respuesta: D**

Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

7.01.3.056 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Consentimiento Informado: El consentimiento informado se aborda en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y en la ley sobre investigación científica en seres humanos en Chile. En adultos, el consentimiento puede ser verbal, pero debe ser informado y voluntario. Para que sea informado, se debe proporcionar toda la información necesaria, incluyendo riesgos, procedimientos y alternativas, antes de obtener el consentimiento. En menores de edad, los padres o tutores legales deben dar su consentimiento, pero los niños tienen derecho a ser escuchados según su edad y madurez. En investigación, se requiere consentimiento previo, expreso, libre e informado del participante, o el consentimiento de la persona que deba suplir su voluntad según la ley, que en el caso de menores son los padres o tutores legales.

PREGUNTA 69 **Respuesta: A**

Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

7.01.3.056 | Dx: Marco Legal Sanitario · Tx: Custodia Documental · Seg: Superintendencia de Salud | GES

A) Correcta. La Ley 20.584 prohíbe de manera taxativa la divulgación o entrega de la ficha clínica a terceras personas no contempladas en la ley. Los empleadores están legalmente excluidos de acceder a la ficha médica de sus subordinados, independientemente de cualquier justificación administrativa laboral. La información sólo puede ser entregada al propio paciente o a quien cuente con un poder notarial expreso. B, C, D, E) Son conductas ilegales que violan el secreto profesional y la confidencialidad de la ficha clínica.

PREGUNTA 70 **Respuesta: A**

Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

7.01.3.056 | Dx: Marco Legal Sanitario · Tx: Custodia Documental · Seg: Superintendencia de Salud | GES

A) Correcta. El artículo 13 de la Ley 20.584 y su respectivo reglamento (Decreto Supremo N.° 41 del MINSAL) señalan expresamente que los prestadores institucionales de salud deberán conservar y resguardar las fichas clínicas por un período mínimo de 15 años, contados desde la última vez que el paciente recibió una atención de salud en el establecimiento. B, C, D, E) Son plazos erróneos que no concuerdan con el mandato de la ley chilena.

PREGUNTA 71 **Respuesta: A**

Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

7.01.3.056 | Dx: Marco Legal Sanitario · Tx: Custodia Documental · Seg: Superintendencia de Salud | GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad, la conducta médica prioritaria es: La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 72 **Respuesta: A**

Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

7.01.3.056 Dx: Marco Legal Sanitario · Tx: Custodia Documental · Seg: Superintendencia de Salud GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad, la conducta médica prioritaria es: La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

BLOQUE 5 BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: B**

Dirección: funciones de la dirección, liderazgo, comunicaciones, coordinación

7.01.3.045 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Es una pregunta muy discuGble, ya que no hay ninguna obligación de informar a la prensa acerca de estos hechos y, por el contrario, la ley 20.585 (conocida como Ley de Derechos y Deberes del Paciente) establece la información de salud como confidencial. Sin embargo, de las opciones, la única aceptable es la Dirección del Hospital, por ser quien Gene la vocería institucional y, en la práctica, es quien da esta información, pero de manera muy superficial (ej. número de pacientes y gravedad, pero sin indicar nombres específicos).

PREGUNTA 74 **Respuesta: B**

Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

7.01.3.051 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 52). Evalúa el manejo clínico de Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 75 **Respuesta: A**

Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

A) Correcta. La Causa Básica de Defunción se define como la enfermedad o lesión inicial fundamental que desencadenó la secuencia patológica que condujo directamente a la muerte. En este caso, la cirrosis hepática fue la patología etiológica subyacente que generó la hipertensión portal, la formación de várices esofágicas (causa intermedia) y finalmente la rotura hemorrágica masiva con shock (causa inmediata). Por lo tanto, 'Cirrosis hepática' es la causa básica que debe consignarse en el renglón inferior de la Parte I. B) Incorrecta. El paro cardiorrespiratorio es un mecanismo inespecífico terminal formalmente prohibido como causa básica. C) Incorrecta. El shock hipovolémico corresponde a la causa inmediata terminal. D) Incorrecta. La rotura varicosa es la causa intermedia de la cadena.

PREGUNTA 76 **Respuesta: A**

Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

A) Correcta. El artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal establece que los médicos, cirujanos, enfermeros y demás profesionales de la salud tienen el deber ineludible de denunciar los delitos de acción pública (entre los cuales se encuentran las lesiones corporales graves en el contexto de violencia intrafamiliar) que tomaren conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión. El artículo 176 fija un plazo fatal estricto de VEINTICUATRO HORAS (24 horas) para efectuar la denuncia ante la Fiscalía, Carabineros o PDI. B) Incorrecta. El deber de denuncia es una obligación legal imperativa del médico, no supeditada a la voluntad o autorización de la víctima. C) Incorrecta. El plazo perentorio legal es de 24 horas, no 72 horas. D, E) Son conductas imprudentes que exponen a la víctima a mayor peligro y constituyen omisión de denuncia.

PREGUNTA 77 **Respuesta: D**

Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

7.01.3.051 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Falla respiratoria

PREGUNTA 78 **Respuesta: C**

Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

7.01.3.051 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Certificado de defunción, licencia médica, notificación de enfermedades.

PREGUNTA 79 **Respuesta: A**

Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia, la conducta médica prioritaria es: Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 80 **Respuesta: A**

Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia, la conducta médica prioritaria es: Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 81 **Respuesta: A**

Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia, la conducta médica prioritaria es: Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 82 **Respuesta: A**

Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

7.01.3.051 Dx: Certificación de Muerte · Tx: Llenado Normativo CMD · Seg: Servicio Médico Legal / Fiscalía GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia, la conducta médica prioritaria es: Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 83 **Respuesta: A**

Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

7.01.3.054 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Amigdalitis aguda

PREGUNTA 84 **Respuesta: A**

Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

7.01.3.054 Dx: Marco Normativo Especial · Tx: Procedimiento Legal · Seg: COMPIN / SUSESO / MINSAL GES

A) Correcta. La Ley 21.030 establece que, para la Causal 3 (embarazo por violación), el plazo máximo de gestación para realizar la interrupción médica es de hasta 12 semanas; sin embargo, la propia ley establece una excepción explícita que amplía el plazo hasta las catorce semanas de gestación (14 semanas) tratándose de niñas menores de catorce años de edad. Al tener la paciente 13 años y cursar 13 semanas y 4 días, se encuentra dentro del marco legalmente permitido. B) Incorrecta. La regla general es 12 semanas, pero la ley contempla la prórroga a 14 semanas en menores de 14 años. C) Incorrecta. No se exige denuncia penal ni sentencia judicial previa para la atención de salud bajo causal 3. D, E) No concuerdan con los preceptos de la Ley 21.030.

PREGUNTA 85 **Respuesta: A**

Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

7.01.3.054 Dx: Marco Normativo Especial · Tx: Procedimiento Legal · Seg: COMPIN / SUSESO / MINSAL GES

A) Correcta. La Ley 20.585 otorga facultades fiscalizadoras estrictas a la COMPIN y SUSESO, y tipifica penalmente la emisión fraudulenta de licencias médicas. Las sanciones judiciales contemplan penas de presidio menor en sus grados medio a máximo (cárcel efectiva), multas económicas gravosas a beneficio fiscal (de 50 a 500 UTM) e inhabilitación para otorgar licencias médicas y ejercer cargos públicos por hasta 3 a 5 años, pudiendo llegar a la inhabilitación perpetua en casos de reincidencia o crimen organizado. B, C, D, E) Subestiman drásticamente la gravedad punitiva de la ley, la cual tipifica el hecho como delito penal de estafa y falsedad ideológica contra el fisco.

PREGUNTA 86 **Respuesta: D**

Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

7.01.3.054 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Otorgamiento, uso y sanciones por mal uso de licencias médicas.

PREGUNTA 87 **Respuesta: A**

Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

7.01.3.054 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Caso clínico oficial EUNACOM para Otorgamiento, uso y sanciones por mal uso de licencias médicas.

PREGUNTA 88 **Respuesta: A**

Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

7.01.3.054 Dx: Marco Normativo Especial · Tx: Procedimiento Legal · Seg: COMPIN / SUSESO / MINSAL GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas, la conducta médica prioritaria es: Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 89 **Respuesta: A**

Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

7.01.3.054 Dx: Marco Normativo Especial · Tx: Procedimiento Legal · Seg: COMPIN / SUSESO / MINSAL GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas, la conducta médica prioritaria es: Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.

PREGUNTA 90 **Respuesta: A**

Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

7.01.3.054

Dx: Marco Normativo Especial · Tx: Procedimiento Legal · Seg: COMPIN / SUSESO / MINSAL

GES

La opción A es la respuesta correcta. Según el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las guías de práctica clínica para Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas, la conducta médica prioritaria es: Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).. Las demás opciones representan conductas diferidas o inapropiadas en el nivel primario.